

イー症)などが遺伝することを、たいていの人は知るようになった。

つれあいがそういう病気をもちなくても、どちらかの親のきょうだいにそういう病気があった場合に、自分たちの子どもがそういう病気にかからないだろうかという心配がおこる。悲観論になって、はじめから子どもをつくらないことにきめるのはよくない。遺伝相談をするところについて相談をしてからきめるべきだ。それには問題にしている病気の診断がはっきりしていないと話にならない。その人のくわしい病歴をまずそろえねばならない。そのつぎに家系図をつくって、ほかにそういう病気の人があったかどうかをしらべる。2代前でも3代前でも、わかっているかぎりさかのぼる。この病歴と家系図をもって相談所に行く。

病気が女の保因者(外見は健康だが染色体に病気をこす遺伝子をもつ)を介して、つぎの代にあらわれることが少なくない。母親が保因者でも、娘は全部保因者とはかぎらない。血友病、デュシエンヌ型の筋ジストロフィー、フェニールケトン尿症、ガラクトース血症などは、保因者かどうかをしらべる方法がみつかっている。保因者でなかったら、遺伝の心配をする必要がない。

また夫婦のどちらも正常なのに、ひとり子どもができて、その子が奇形をもっている場合も、つぎの子が心配になる。

これもその可能性がわかっていいるのがある。脊椎せきついひ裂ひれつだと6%、口唇裂こうしんれつだと4%、口蓋裂こうがいれつだと3%、

股関節脱臼こかんせつだつぎゅうだと14%といった数字がでている。

染色体の異常でおこる難病を、胎児のあいだに見つけて、人工流産する方法に、妊婦から羊水をとって、胎児の細胞をしらべる羊水診断がある。これは妊娠16週(5カ月)以後でないとできない。人工流産は5カ月になると危険なので、もっと早く診断できないかというので、胎盤の胎児側の絨毛じゅうもうをとってしるべる絨毛診断ができた。これは妊娠9~11週でできる。どちらも、胎盤をきずつけるので流産の危険があるので、胎盤を通してもれてくる胎児の赤血球を、妊婦の血液から見つけてしるべる法が開発された。

病気をこす遺伝子が特定の染色体の1カ所にあるものは、胎児の血液や肝の細胞を採取し、分子生物学的にDNA解析をして診断ができる。

胎児診断でわかる異常はダウン症、脊椎披裂、フェニールケトン尿症、血友病、胎児赤芽球症、感染症(風疹ふうしん、単純ヘルペス、サイトメガロウイルス)などである。

障害のある子をもつかもたぬかは、生まれてくる子の養育、きょうだいの将来、家庭の保存について責任のある親が決定すべきである。責任も能力もない第三者の干渉することでない。

5 ハネムーンぼうこう炎

結婚の式がすむと、新郎新婦が新婚旅行にでかけ